

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 2223 286 5379 / 321

AURIMAR DINIZ DE OLIVEIRA

IDADE: 47 PESO: 82 ALTURA: 1,74 PROFISSÃO: Tec. Segurança Trab.
SINTOMAS: Ronco, cansaço durante o dia, engasgo presenciado

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Nenhum Colúterol Resorvatina

MÉDICO: Dr. Enice

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 4x semana

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 08h ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 22h

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 7h ±

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: (X) S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: não

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 57,4h SPO2: 69%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS 1^o grau diabético

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA (N) OUTROS:

03/10/24 Avaliação Swift Ex (M)

10/10/24 P=4-10 cmH₂O / P=60 cmH₂O
IAH= 1,8 cmH₂O

m de uso: 6h 54'
fuga: 3,8 l/min

Bem adaptado
Natacha

21/10/24 P=6 cmH₂O
24 IAH= 1,9 cmH₂O 4^o n.º de horas nos últimos dias.
m de uso: 4h 40'
fuga= 19,6 l/min. gna.

30/10/24 P=6 cmH₂O
IAH= 2,2 cmH₂O Bem adaptado
m de uso: 6h 44min
fuga= 10 l/min Silveira

25/02

P=6 auH₂O

25

IAH=1,2 e/h

m de ur: 4 h 53'

fuga: 136 l/m

↓ caiu horas de ur

Oriento a importancia
de usar a noite toda

Natacha

Nome: AURIMAR DINIZ DE OLIVEIRA

Data de Nascimento: 13-5-1977

IMC: 28,08

Sexo: Masculino

Data do exame: 23-08-2024

Peso: 85 kg

Altura: 1,74 m

Médico: DR. ENIO NARUHIRO KOKUBU

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 23-08-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 525,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 33,0 e 144,0 minutos. O tempo total de sono foi de 415,0 min, eficiência de 79,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 68,9%; estágio N3: 11,1%; sono REM: 17,7%. O índice de despertares foi de 30,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 57,1/hora, sendo 29 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 349 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 69%, permanecendo 17,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 91 bpm e NREM de 56 - 92 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 57,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=69%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

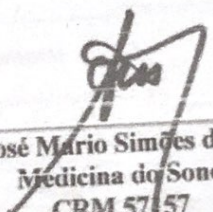
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157